

La maladie de La Peyronie provoque une cicatrice (plaque) dans le pénis qui peut le courber lors d'une érection, rendant parfois les rapports difficiles. La plicature pénienne redresse la courbure en plaçant des points de suture du côté le plus long du pénis pour le « pincer » doucement, afin qu'il corresponde au côté plus court. Ce document explique son fonctionnement, comment vous préparer et ce à quoi vous attendre.

À propos de cette intervention

Dans la maladie de La Peyronie, le tissu cicatriciel tire un côté du pénis, provoquant une courbure à l'érection. La plicature redresse le pénis en suturant et en raccourcissant le **côté le plus long (externe)** de la courbure jusqu'à ce que les deux côtés s'équilibrent. Aucune cicatrice n'est incisée et aucune greffe n'est utilisée — c'est l'opération de redressement la plus simple, avec le **risque le plus faible de nouveaux problèmes d'érection**.

C'est un bon choix lorsque :

- Votre courbure est modérée et non complexe
- Vos **érections sont bonnes** (avec ou sans médicaments)
- Votre pénis est assez long pour qu'un léger raccourcissement soit acceptable

Ce qu'il faut savoir

Le principal compromis est un **raccourcissement** du pénis — généralement 1–2 cm. Beaucoup d'hommes le surestiment ; en corrigeant la courbure, la longueur utile et droite est souvent aussi bonne qu'avant. Environ **9 hommes sur 10** obtiennent une érection suffisamment droite pour les rapports. Il est possible de **sentir les points** sous la peau (fréquent, généralement sans gêne). L'objectif est un pénis suffisamment droit pour des rapports confortables, pas nécessairement parfaitement droit.

COMPRENDRE LES TERMES

Maladie de La Peyronie

Une cicatrice dans le pénis qui le fait courber lors d'une érection.

Plaque

La zone de tissu cicatriciel à l'origine de la courbure.

Plicature pénienne

Redressement du pénis par suture et raccourcissement du côté le plus long.

Érection artificielle

Érection créée en salle d'opération (par injection) pour que le chirurgien mesure et vérifie la courbure.

Circoncision

Ablation du prépuce — parfois réalisée en même temps si vous n'êtes pas circoncis.

Dispositif à vide

Pompe parfois utilisée pendant la cicatrisation pour préserver la longueur et les érections.

Anesthésie générale

Médicament qui vous maintient endormi et sans douleur pendant l'intervention.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention se déroule sous anesthésie générale, rachidienne ou locale : vous ne sentez rien. Ensuite, le pénis est gonflé, marqué d'ecchymoses et douloureux pendant 1–2 semaines — glace, soutien et antidouleurs aident. Opération courte (souvent une heure), généralement en ambulatoire. Une sonde peut être posée brièvement.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Réalisée sous **anesthésie générale, rachidienne ou locale** — suivez toutes les instructions chirurgicales (jeûne, médicaments à suspendre, dont les anticoagulants).
- Votre maladie de La Peyronie doit être **stable** (courbure et douleur stabilisées depuis plusieurs mois) — votre chirurgien confirme le bon moment.
- **Ne fumez pas** ; toute infection est traitée au préalable et vous recevrez des antibiotiques. Si vous n'êtes pas circoncis, une circoncision peut être réalisée en même temps — demandez à votre chirurgien.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Avez des **érections faibles** ou prenez un médicament pour les érections
- Prenez un anticoagulant ou avez déjà subi une chirurgie pénienne

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi ou insensibilisé sous anesthésie, et des antibiotiques sont administrés.
- 2 Une **érection est provoquée par injection** afin que le chirurgien visualise la courbure, puis des points sont placés du côté le plus long pour pincer et redresser le pénis.
- 3 Le résultat est vérifié avec une nouvelle érection, puis la peau est refermée (une circoncision peut être réalisée simultanément si nécessaire).

Après la chirurgie

- Attendez-vous à un **gonflement, des ecchymoses et des douleurs** pendant 1–2 semaines. Utilisez la glace, des sous-vêtements de soutien et des antidouleurs ; gardez la zone propre.
- Si une sonde a été posée, elle est retirée le lendemain matin.
- **Évitez les rapports pendant 4–6 semaines** pour permettre la cicatrisation.
- Votre équipe peut prescrire un **médicament à faible dose** et/ou un **dispositif à vide** quotidien pendant la guérison pour préserver longueur et érections.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons, ou une rougeur, douleur, gonflement ou écoulement croissant à la plaie
- Une impossibilité d'uriner
- Un gonflement ou une douleur sévère ou croissant, ou un saignement abondant

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La plicature redresse la courbure en suturant le côté le plus long du pénis — sans incision de cicatrice ni greffe. C'est l'opération de redressement la plus simple, avec le risque le plus faible de nouveaux problèmes d'érection.
2. Le compromis est un **raccourcissement** (généralement 1–2 cm), mais corriger la courbure restaure souvent la longueur utile ; ~9 hommes sur 10 obtiennent une érection satisfaisante.
3. Votre maladie de La Peyronie doit être stable ; ne fumez pas. Ensuite, évitez les rapports ~4–6 semaines et suivez le plan de guérison (médicament / dispositif à vide).